

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 5

Alteraciones del pie

Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio

TEMARIO:



PIE PLANO, PIE CAVO

ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA ARTICULAR

ETIOPATOGENIA

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO

DEFORMACIONES DEL PIE:

ANTEPIE ADUCTO, PIE BOTT, DEFORMIDADES DE LOS DEDOS

ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA ARTICULAR

ETIOPATOGENIA

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO Y QUIRÚRGICO

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO

Tobillo-pie

Huesos:

Articulaciones:

Movimientos:

Ligamentos:

Músculos:

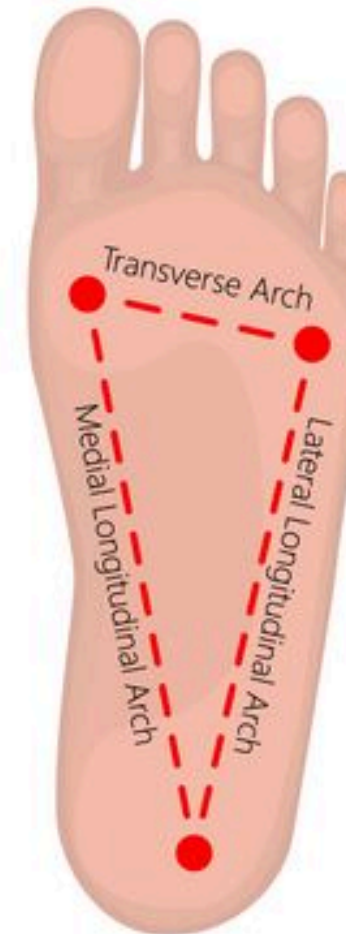


ARCOS DEL PIE

- Apoyar y proteger el pie
- Redistribuir la presión durante la carga dinámica
- Alterar la flexibilidad y rigidez del pie.

ARCHES OF THE FOOT

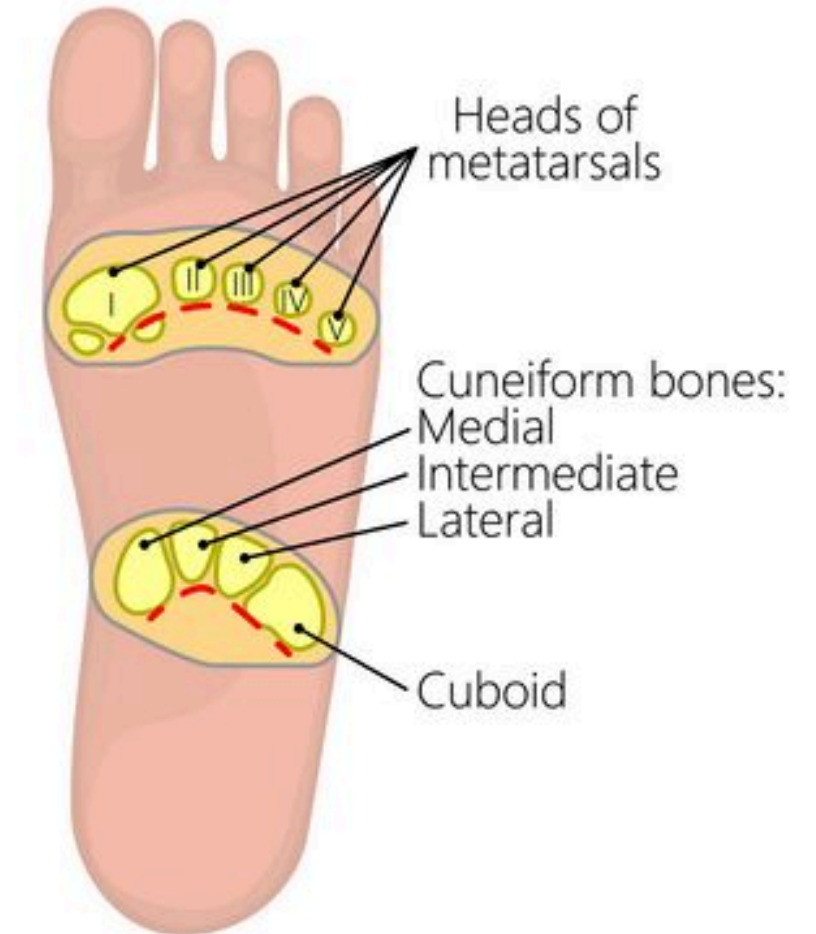
Sole



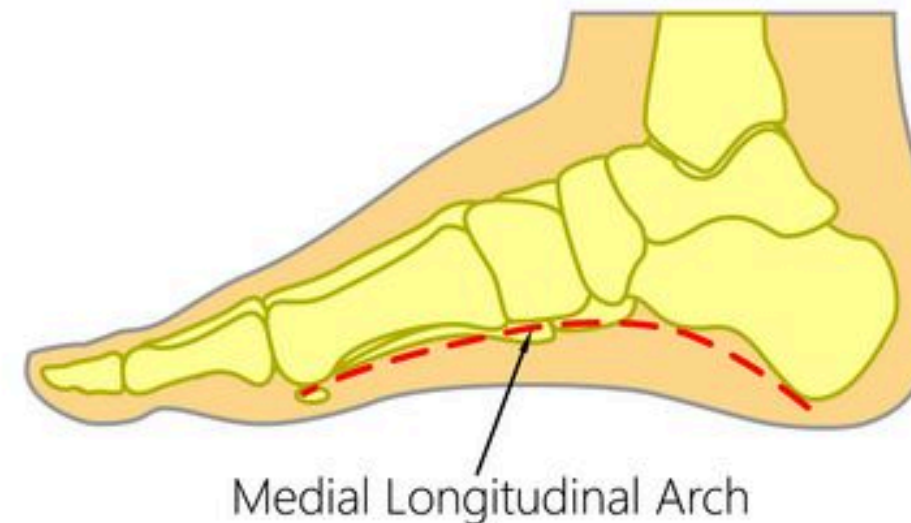
Foot
(bottom view)



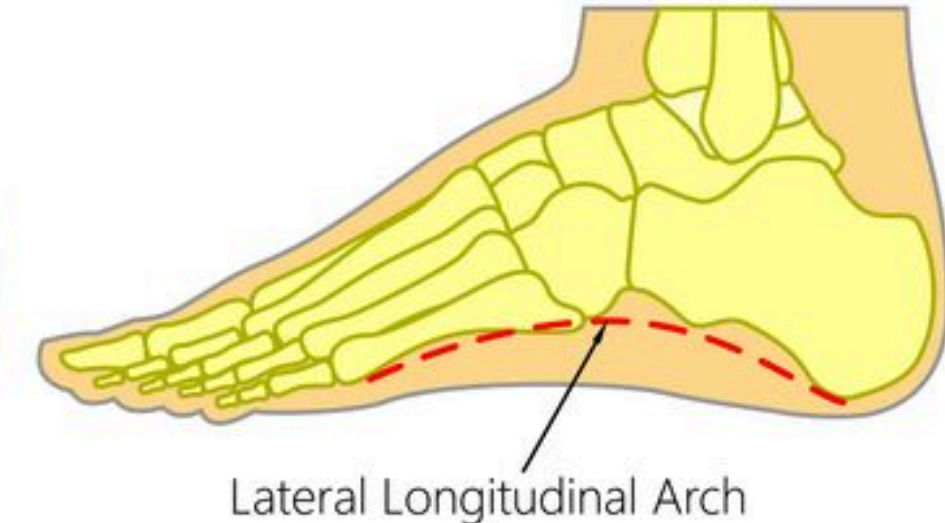
Transverse Arch
(cross section)



Medial view of the foot



Lateral view of the foot

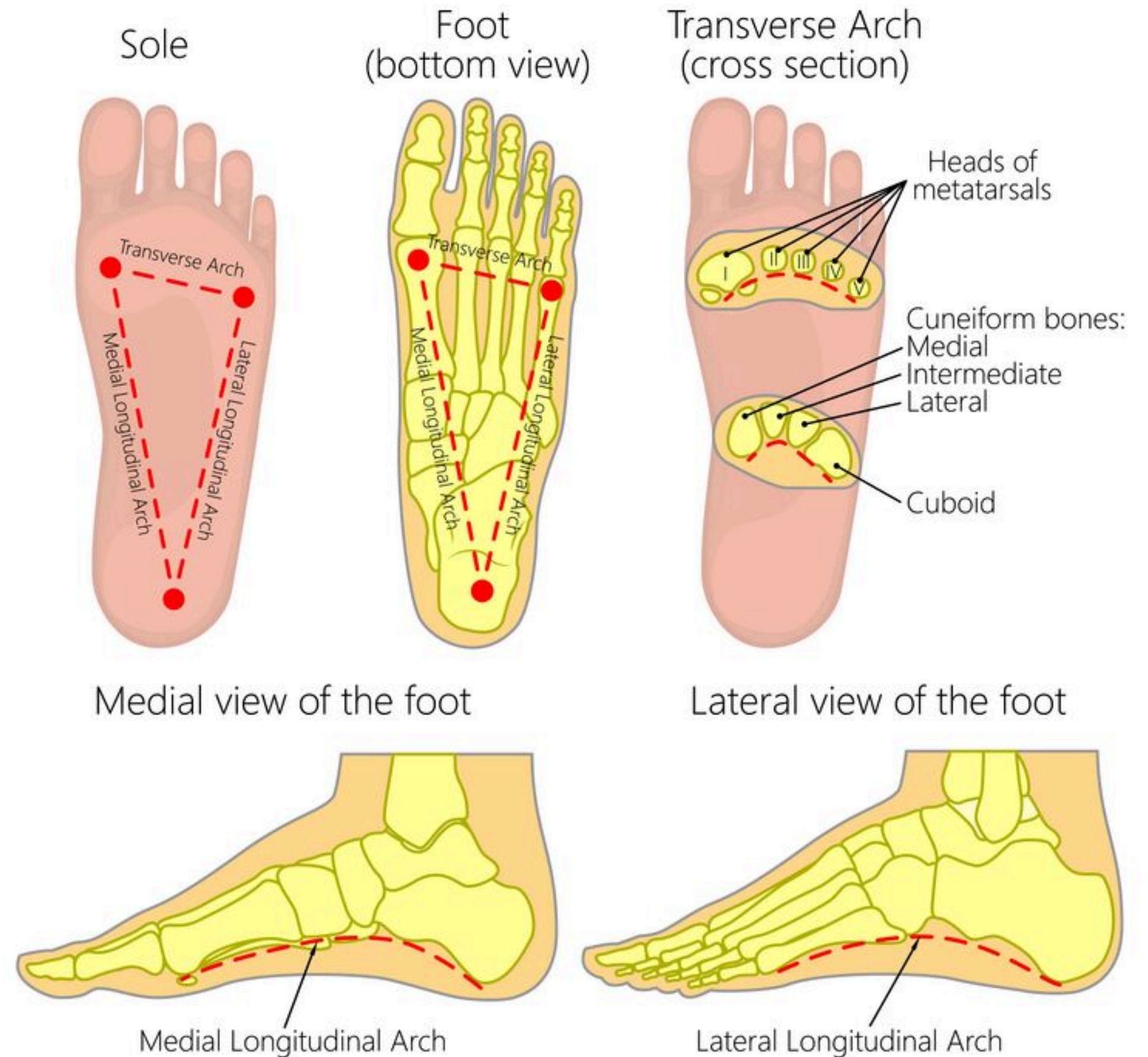


Arco longitudinal lateral : formado por el calcáneo, el cuboides y los dos metatarsianos laterales.

Arco longitudinal medial : formado por el calcáneo, el astrágalo, el navicular, tres cuneiformes y los tres metatarsianos mediales.

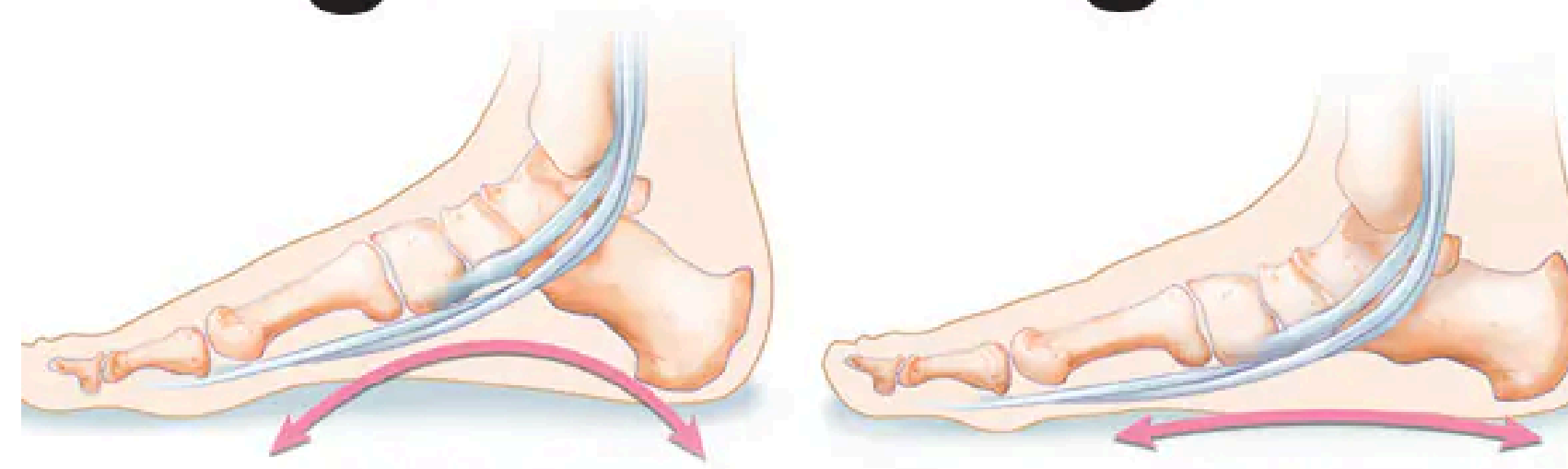
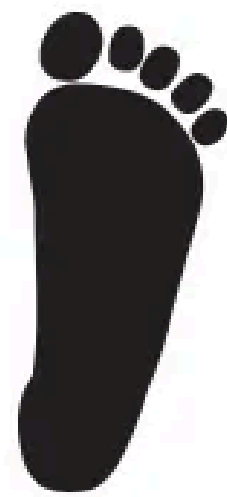
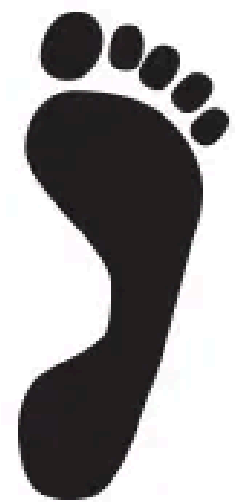
Arco transversal : recorre las articulaciones tarsometatarsianas.

ARCHES OF THE FOOT



PIE PLANO

El pie plano es la pérdida del arco longitudinal medial del pie , la deformidad del talón valgo y la prominencia medial del astrágalo .





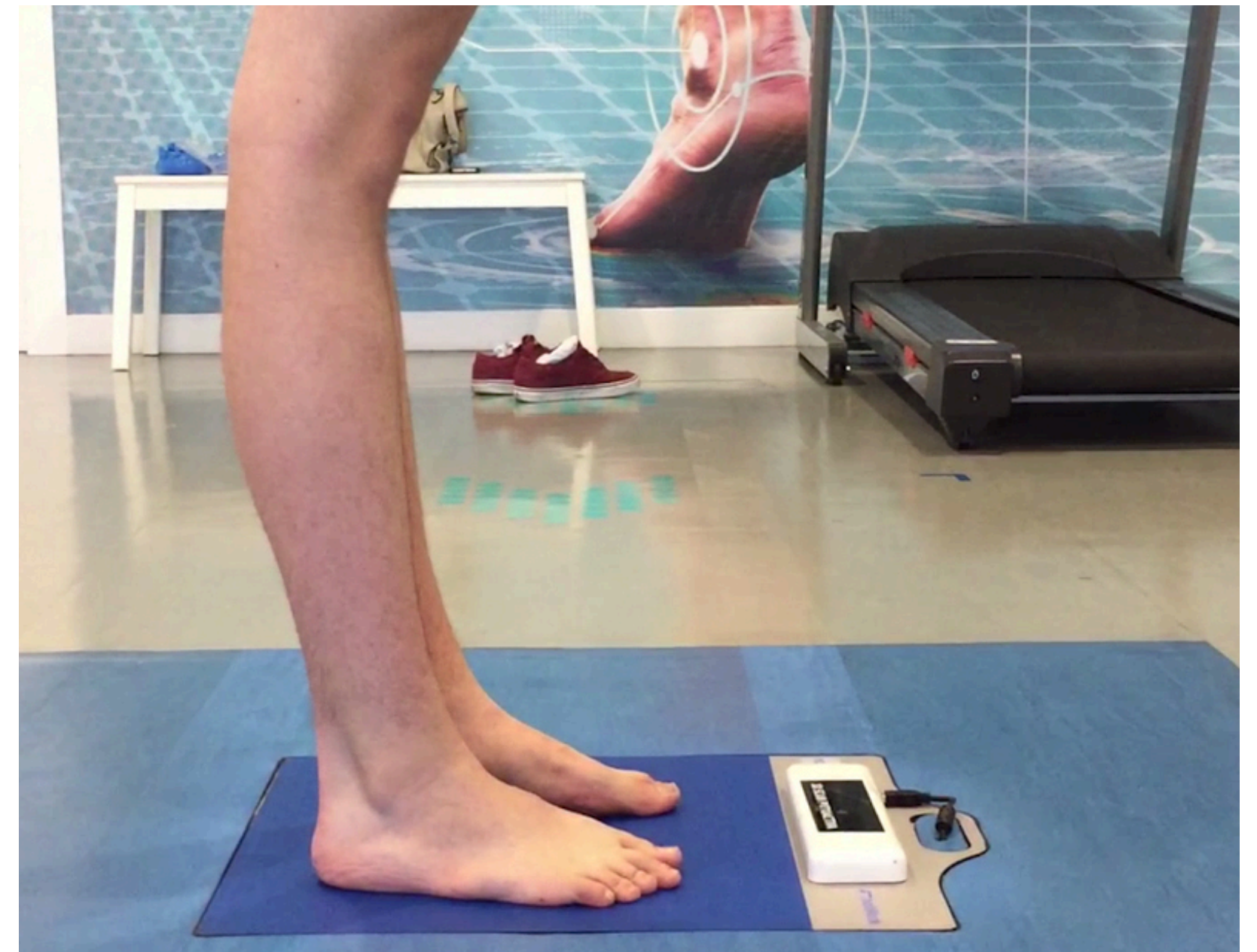
La etiología del pie plano tiene varios factores implicados y puede ser ***congénita o adquirida***.

Afecciones con aumento del tono

Hipermovilidad general/global

Síndrome de Down y el síndrome de Marfan

Deformidad torsional tibial



La etiología del pie plano tiene varios factores implicados y puede ser ***congénita o adquirida***.

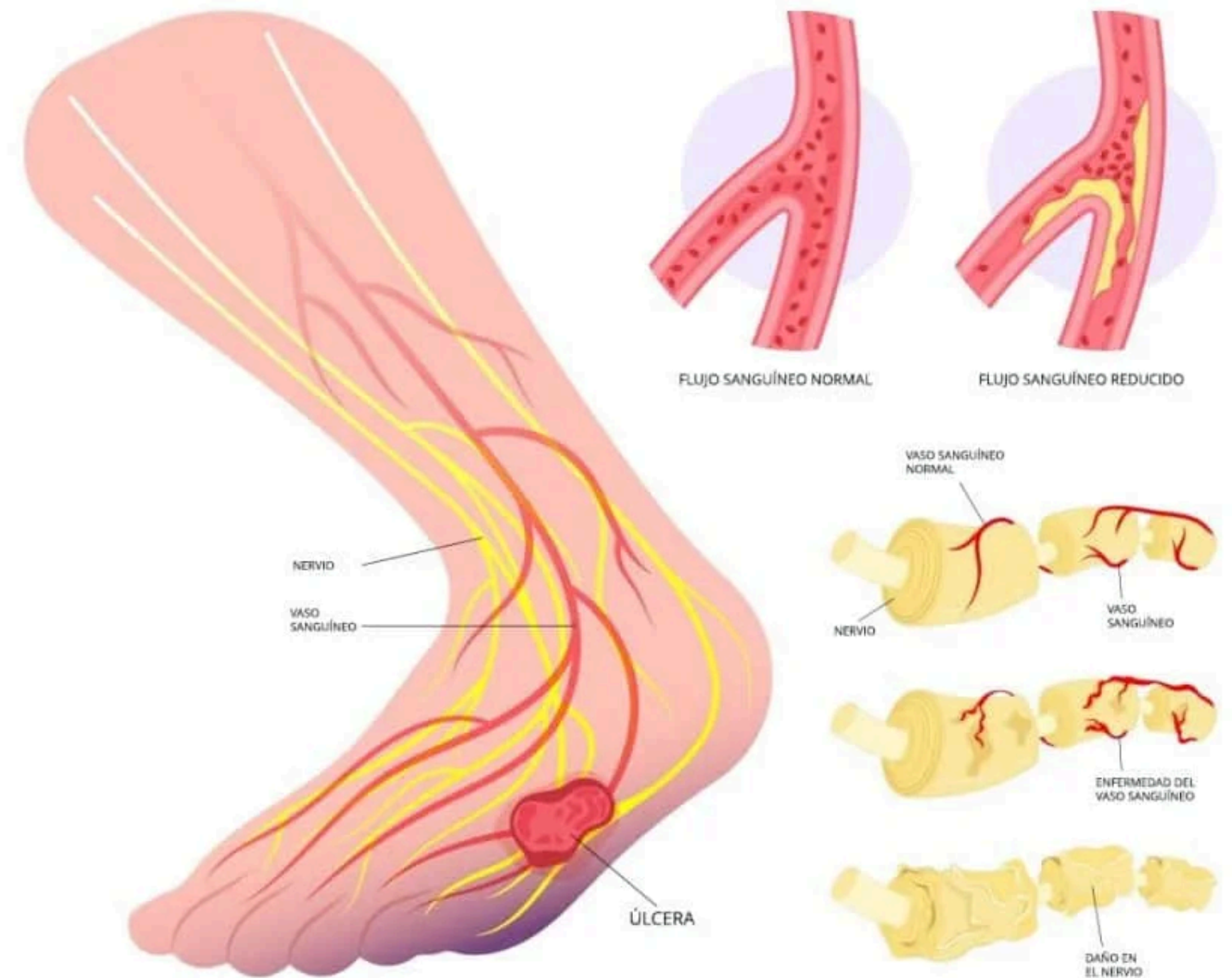
Diabetes

Lesión del pie y del tobillo

Artritis

Lesión traumática

NEUROPATÍA DIABÉTICA

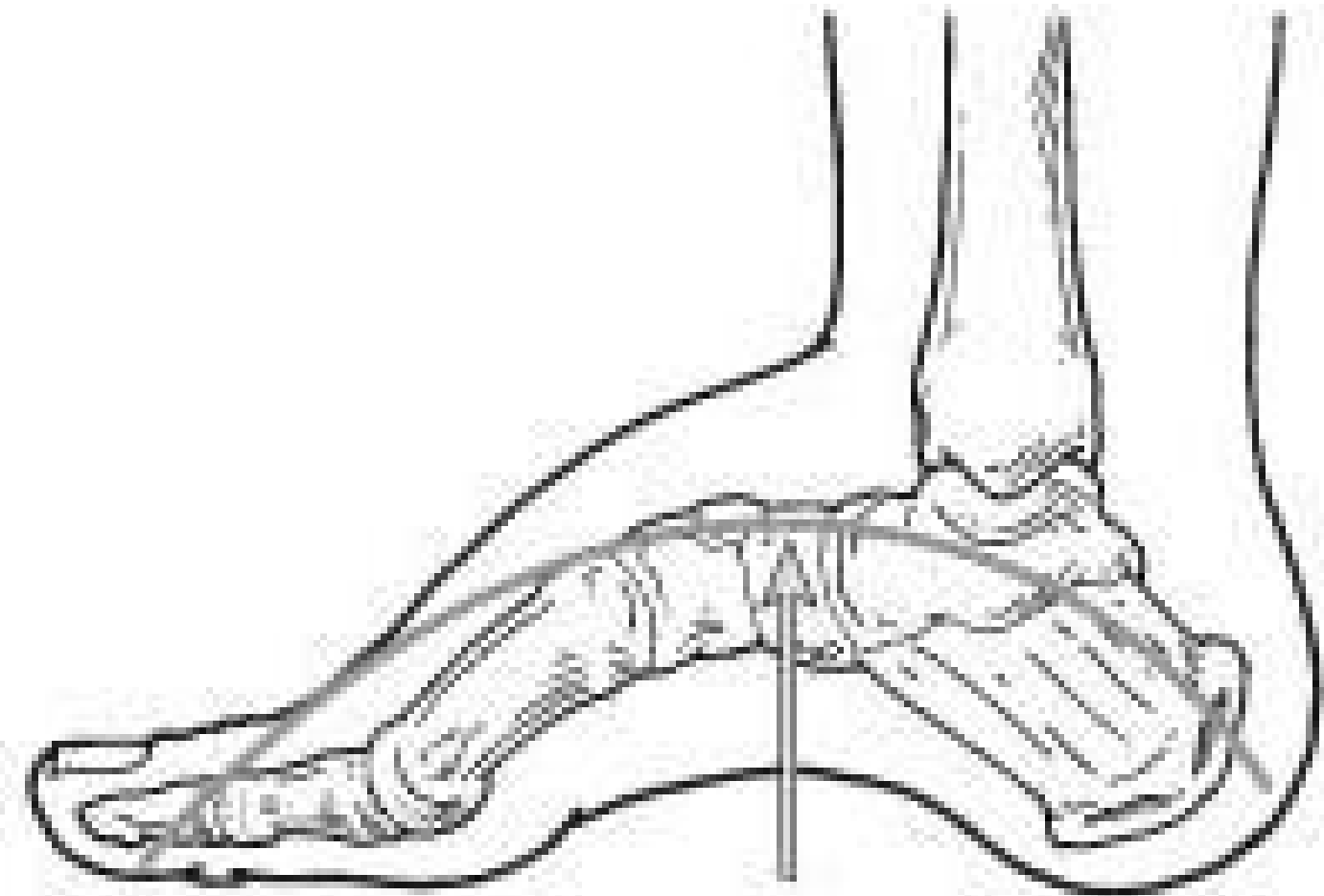


PIE CAVO

El pie cavo es un pie con un arco longitudinal plantar anormalmente alto.



Normal Foot



Cavus Foot

La etiología del pie cavo puede ser neuromuscular, traumática, congénita o idiopática.

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth

Parálisis cerebral

Espina bífida

Fracturas

Quemaduras





**Calzado diseñado para paciente
con pie valgo**
(desviación del tobillo hacia adentro)



Los grados de inclinación de la suela ayudan
a direccionar el tobillo en la posición correcta





El objetivo de la fisioterapia será:

- Minimizar el dolor.
- Aumentar la flexibilidad del pie.
- Fortalecer los músculos débiles.
- Entrenar la propiocepción.
- Educar al paciente

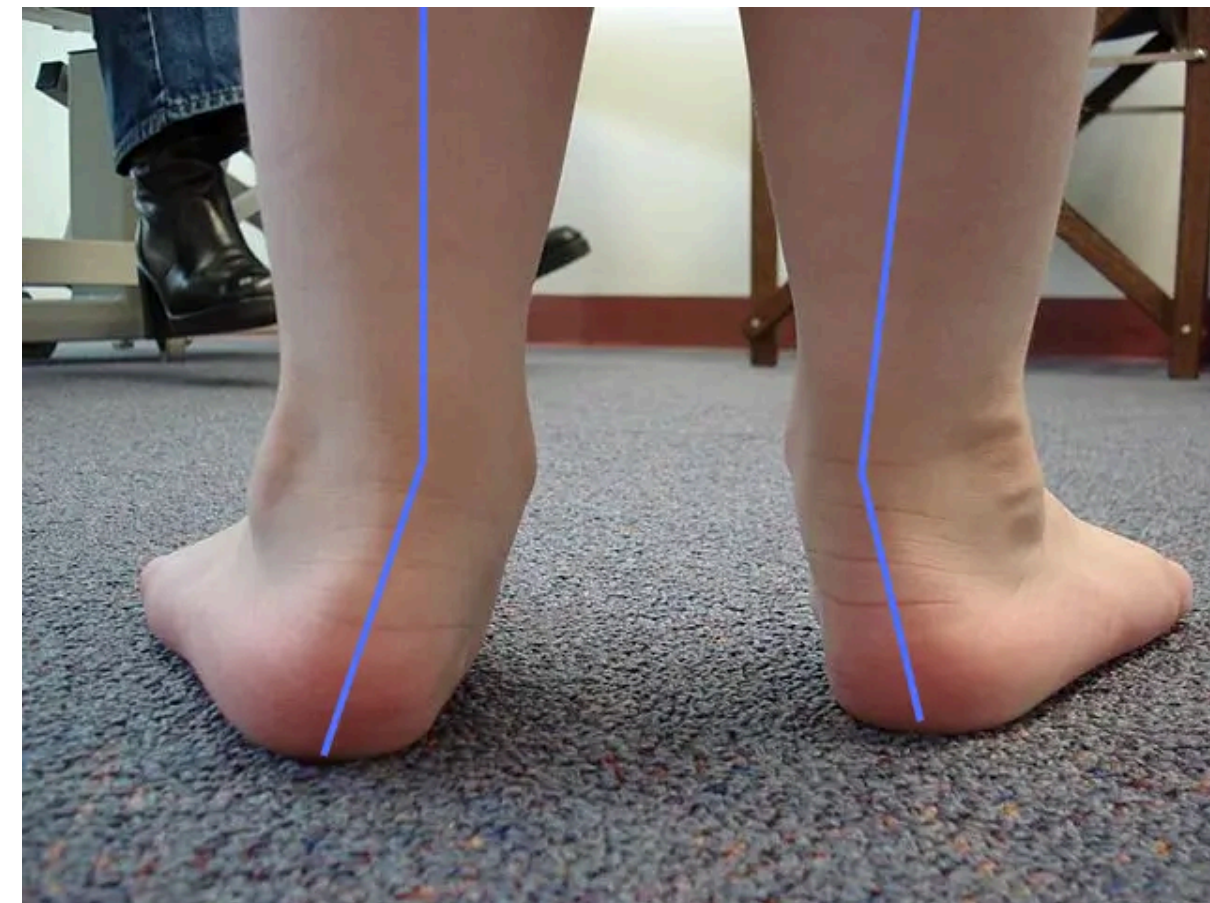


Fomentar el caminar con los pies en la tierra.

PIE PLANO

Los ejercicios de flexibilidad son ejercicios pasivos de ROM del tobillo y todas las articulaciones del pie.

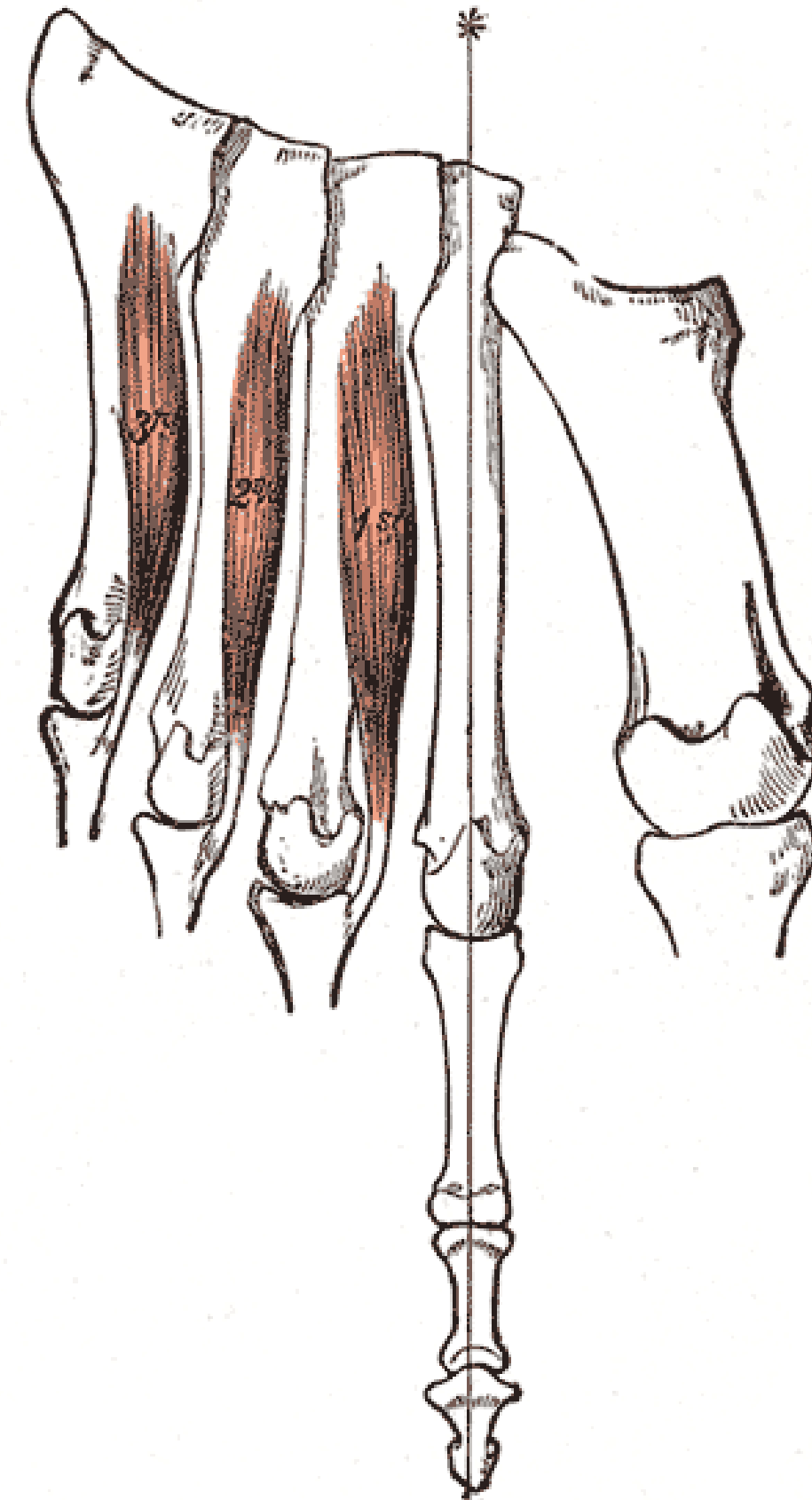
- Estiramiento gastrocnemio sóleo y los músculos peroneo corto para facilitar el varo y la aducción del pie.
- Estiramiento del tendón del talón para el tendón de Aquiles y los músculos de la pantorrilla.



PIE PLANO

Ejercicios de fortalecimiento :

- **Músculos** tibiales anterior y posterior, el flexor largo del dedo gordo, los músculos intrínseco e interóseo plantar y el abductor del dedo gordo para prevenir el valgo y el aplanamiento del arco.



Ejercicios de fortalecimiento :

- Activación global de los músculos que soportan el arco longitudinal medial y el varo con y sin resistencia.
- Carga de peso con una sola pierna.
- Caminar de puntillas.



PIE CAVO

Los ejercicios de flexibilidad son ejercicios pasivos de ROM del tobillo y todas las articulaciones del pie.

- Aponeurosis plantar
- Musculatura acortada
(Extensores de los dedos,
tibial posterior)



Ejercicios de fortalecimiento :

- Interóseos, lumbricales, tibial anterior, tríceps sural.

Redistribuir la presión plantar, mediante el uso de ortesis plantares y calzado acolchado especializado.

PIE CAVO



ARCO NORMAL

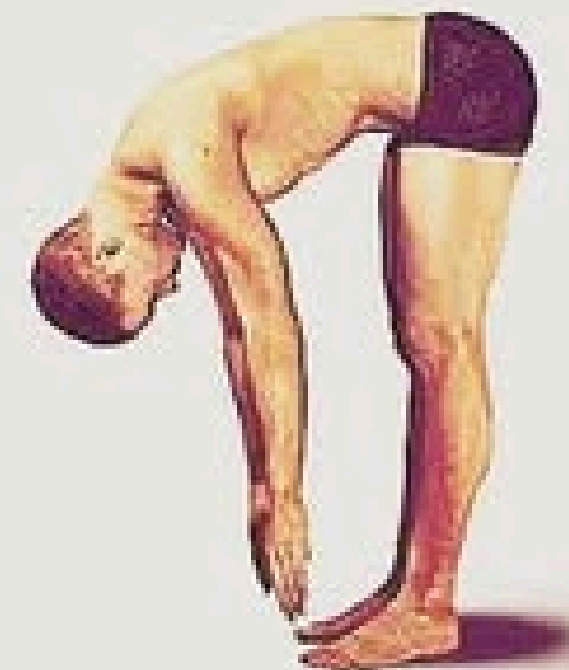
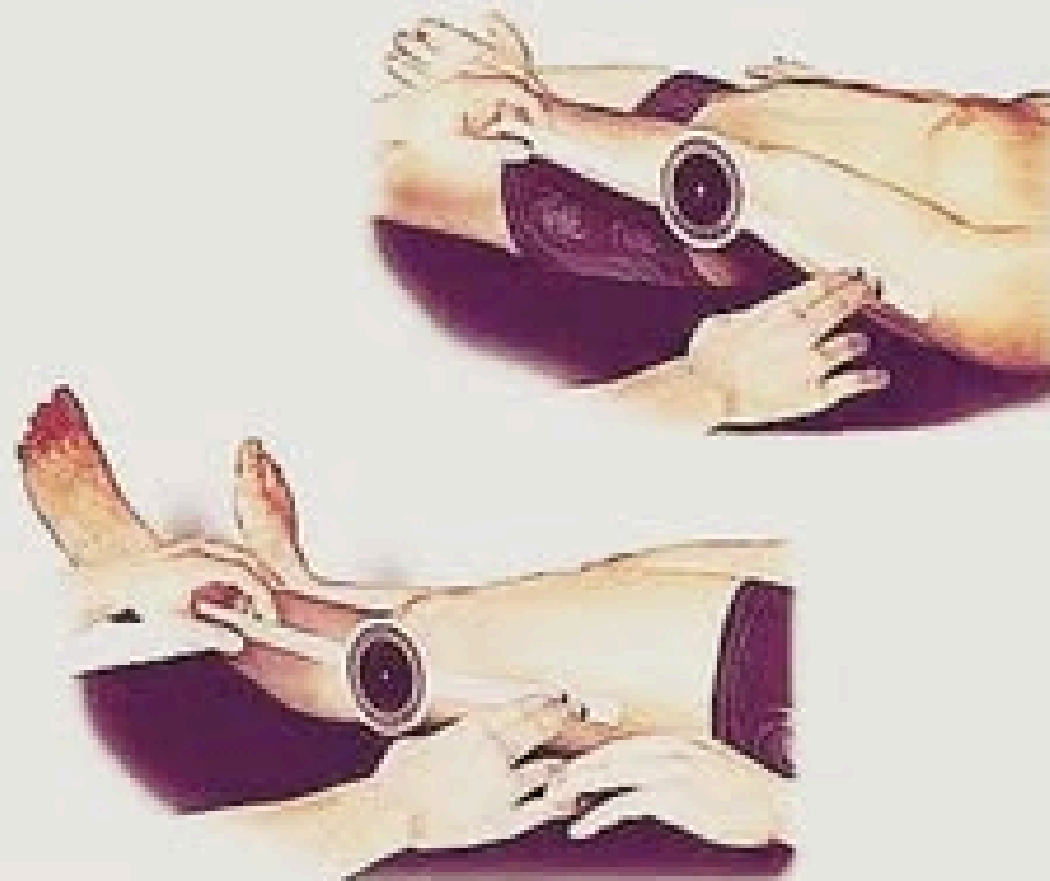


PIE PLANO



Tabla I. Hiperlaxitud articular: criterios de Beighton, 1973^{10,11}

Maniobra	Derecho	Izquierdo
Aposición del pulgar al antebrazo	1	1
Dorsiflexión del 5º dedo $\geq 90^\circ$	1	1
Hiperextensión del codo $\geq 10^\circ$	1	1
Hiperextensión de la rodilla $\geq 10^\circ$	1	1
Flexión del tronco tocando el suelo con las palmas	1	
Una puntuación ≥ 4 es compatible con hiperlaxitud articular		



Caso clínico

- **PIE BOT**
- **Plagiocefalia**
- **Dismetría de extremidades inferiores**
- **Osteomielitis y artritis séptica**

- Definición
- Síntomas
- Edad
- Diagnóstico
- Tratamiento
ortopédico

- 1. ¿Qué es el genu valgo?**
- 2. Indique 3 signos de ESCOLIOSIS.**
- 3. Articulación de la cadera:**
 - a. Tipo de articulación**
 - b. Movimiento en plano sagital**
 - c. Movimiento en plano frontal**
 - d. Movimiento en plano transversal**

Muchas gracias

Presente.